

Dossier d'adressage · Partie Médicale

(à remplir par le médecin adressant)

Le **DPL TDAH** des Makaras est un **outil d'appui aux médecins** : il permet une **télé-expertise entre le médecin adressant et l'équipe** sur la question du TDAH de l'adulte. **Les Makaras ne reçoivent pas les patients en consultation pour le TDAH directement.** Ce dossier recueille les éléments nécessaires à l'étude de votre demande. Il comporte **deux volets** :

- ☐ La **partie du patient**, à compléter par le patient lui même
- ☐ La **partie médicale**, à compléter par le médecin adresseur. Cette partie est à **transmettre directement aux Makaras** (courrier ou courriel à UMAA@ch-valvert.fr), sans forcément transiter par le patient

Les **deux volets sont étudiés conjointement** afin de proposer une télé-expertise avec le médecin adressant, ou une orientation vers une évaluation spécialisée.

- ❖ Un suivi médical régulier du patient est nécessaire pour l'étude de la demande.
- ❖ Le dossier n'est étudié qu'après réception des deux volets, complétés de façon exhaustive.
- ❖ Dispositif réservé aux patients résidant en région PACA.

Identification

Patient(e)

Nom : Prénom :

Date de naissance : Sexe :

Médecin adressant

Nom et prénom :

Adresse (obligatoire) :

Téléphone (obligatoire) :

Courriel (obligatoire) :

Date de début du suivi : Fréquence des consultations :

1. Motif de la demande

- ☐ Avis diagnostique
- ☐ Avis thérapeutique (échec ou intolérance)
- ☐ Autre

Précisez (le cas échéant) :

2. Observations cliniques

Décrivez, dans la mesure du possible, les éléments observés (exemples concrets, contextes, ancienneté).

Inattention (distractibilité, oublis, étourderies, finalisation des tâches)

.....
.....

Organisation / fonctions exécutives (planification, priorisation, gestion du temps, procrastination)

.....
.....

Mémoire de travail

.....



Hyperactivité (motrice et/ou psychique)

.....

.....

Impulsivité (verbale, comportementale, cognitive - ex : prise de décision - et émotionnelle)

.....

.....

Retentissement fonctionnel

.....

.....

Ancienneté et caractère envahissant des symptômes

Plusieurs symptômes présents avant l'âge de 12 ans ? ☐ Oui ☐ Non ☐ Incertain

Symptômes présents dans au moins 2 contextes (ex. travail, domicile, social) ? ☐ Oui ☐ Non ☐ Incertain

État clinique actuel

.....

.....

Diagnostics différentiels envisagés / comorbidités repérées

.....

.....

En cas de diagnostic déjà posé : anamnèse et évolution depuis le diagnostic

.....

.....

3. Antécédents

Personnels — somatiques / chirurgicaux

.....

.....

Personnels — psychiatriques

☐ Autre trouble du neurodéveloppement ☐ Trouble bipolaire ☐ Dépression ☐ Trouble anxieux

☐ Addictions / TCA ☐ Psychotraumatisme ☐ Trouble de la personnalité ☐ TS / automutilations

Hospitalisation(s) — dates, lieux, motifs :

.....

.....

Familiaux — psychiatriques / neurologiques

☐ TDAH ☐ Autre TND ☐ Trouble bipolaire ☐ Dépression récurrente

☐ Suicide ☐ Addictions ☐ Épilepsie ☐ Troubles du sommeil

Précisez (qui ?) :

.....

.....

4. Mode de vie actuel

.....

.....

.....

.....



5. Comorbidités

Cochez et précisez si besoin sur la ligne « Détails » de chaque item.

Sommeil : ☐ SAOS ☐ Narcolepsie ☐ Hypersomnolence ☐ SJSR ☐ Non recherché

Détails :

Dysthyroïdie : ☐ Oui ☐ Non ☐ Non recherché

Détails :

Anémie / carence martiale : ☐ Oui ☐ Non ☐ Non recherché

Détails :

Épilepsie : ☐ Oui ☐ Non

Détails :

Traumatisme crânien / accidents : ☐ Oui ☐ Non

Détails :

Douleurs chroniques : ☐ Oui ☐ Non

Détails :

Surpoids / obésité : ☐ Oui ☐ Non

Détails :

Comorbidité neurologique / génétique : ☐ Oui ☐ Non

Détails :

Addictologiques : ☐ Oui ☐ Non

Détails :

Psychiatriques diagnostiquées : ☐ Trouble anxieux ☐ Dépressif ☐ Bipolaire ☐ TSA ☐ TCA ☐

Borderline ☐ Traumatique ☐ Autre

Détails :

Trouble de la personnalité suspecté :

Préciser :

6. Historique thérapeutique

Traitement actuel (complet, y compris somatique)

Indiquez l'ensemble des traitements en cours (psychotropes, TDAH et somatiques), avec posologies.

.....

.....

.....

.....

.....

Historique des traitements du TDAH

Molécule	Posologie	Durée	Efficacité	Tolérance	Motif d'arrêt



Historique des autres traitements psychotropes

Molécule	Posologie	Durée	Efficacité	Tolérance	Motif d'arrêt

Approches non médicamenteuses

☐ Règles hygiéno-diététiques / psychoéducation ☐ TCC ☐ Remédiation cognitive ☐ Groupes thérapeutiques ☐ Autre

Détails :

7. Examens complémentaires réalisés

☐ Bilan biologique récent (thyroïde, NFS, ionogramme, bilan hépatique/rénal, ferritine...) — ☐ Normal
☐ Anormal

Si anormal, précisez :

☐ IRM cérébrale Date : Conclusions :

☐ Scanner cérébral Date : Conclusions :

☐ EEG Date : Conclusions :

☐ Bilan neuropsychologique Conclusions :

☐ ECG — ☐ Normal ☐ Anormal (utile avant l'introduction d'un traitement psychostimulant)

☐ Autres :

8. Remarque / information complémentaire (facultatif)

.....
.....
.....
.....

Date :

Signature et cachet du médecin adressant :